

AI 영상치유의 가능성과 한계

— 영상치료(Video Therapy) 기제에 기반한 통합적 비교 고찰 —

Possibilities and Limitations of AI Video Healing: An Integrative Comparative Review Grounded in the Mechanisms of Video Therapy

저자명 1)

1) 소속 기관, 학과 (직위) · 교신저자 이메일: _____

투고일: 20XX. XX. XX. / 수정일: 20XX. XX. XX. / 게재확정일: 20XX. XX. XX.

국문초록

본 연구는 생성형 인공지능(generative AI) 기반 '영상치유'를, 기존 영상치료(video therapy)의 치료 기제에 정박한 통합적 분석틀을 구성하여 그 가능성과 한계를 비판적으로 비교·고찰하는 것을 목적으로 한다. 영상치료는 영화·영상 매체의 시청·제작·재구성을 통해 정서를 환기하고 자기이해와 변화를 돕는 심리치료적 접근으로, 동일시와 투사, 정서적 정화(catharsis), 보편성(universality), 관찰학습, 그리고 치료적 대화의 매개라는 정교한 기제 위에서 발전해 왔다. 최근 텍스트-투-비디오(text-to-video) 생성 모델의 등장으로 개인 맞춤형 영상을 즉시 생성하는 'AI 영상치유'가 새로운 가능성으로 주목받고 있으나, 그 치료적 타당성은 충분히 검토되지 않았다. 본 연구는 이론적 문헌고찰(theoretical literature review)을 통해 영상치료의 다섯 가지 핵심 기제를 분석 렌즈로 통합하고, 이를 적용하여 (1) 접근성·맞춤성·즉시성·표현 확장이라는 가능성과 (2) 치료적 관계의 부재, 의미 처리의 피상화, 근거 부족, 윤리적 위험, 진정성의 문제라는 한계를 체계적으로 대조하였다. 분석 결과, AI 영상치유는 영상치료를 대체하기보다 치료자가 매개하는 보조 도구로 통합될 때 가장 책임 있게 그 잠재력을 실현할 수 있음을 확인하였다. 본 연구는

디지털 치유 기술의 도입을 이론적으로 성찰할 분석틀과 후속 실증연구·정책의 방향을 제시한다.

주제어: AI 영상치유, 영상치료, 영화치료, 생성형 인공지능, 치료적 동맹, 디지털 정신건강

Abstract

This study aims to critically compare the possibilities and limitations of generative artificial intelligence (AI)-based "video healing" by constructing an integrative analytic framework grounded in the therapeutic mechanisms of established video therapy. Video therapy is a psychotherapeutic approach that evokes emotion and facilitates self-understanding and change through the viewing, creation, and reconstruction of film and video media; it has developed upon sophisticated mechanisms such as identification and projection, emotional catharsis, universality, observational learning, and the mediation of therapeutic dialogue. With the emergence of text-to-video generative models, "AI video healing," which instantly generates personalized visual content, has drawn attention as a new possibility, yet its therapeutic validity has not been sufficiently examined. Through a theoretical literature review, this study integrates five core mechanisms of video therapy into an analytic lens and applies it to systematically contrast (1) possibilities—accessibility, personalization, immediacy, and the expansion of expression—and (2) limitations—the absence of a therapeutic relationship, the superficialization of meaning processing, the lack of evidence, ethical risks, and the problem of authenticity. The analysis confirms that AI video healing can most responsibly realize its potential when integrated as a therapist-mediated supportive tool rather than as a replacement for video therapy. This study provides an analytic framework for theoretically reflecting on the adoption of digital healing technologies and offers directions for future empirical research and policy.

Keywords: AI video healing, video therapy, cinema therapy, generative AI, therapeutic alliance, digital mental health

I. 서론

1. 연구의 배경

영상은 인간의 정서에 직접적이고 강력하게 작용하는 매체이다. 한 편의 영화나 짧은 영상이 관객의 감정을 환기하고, 억압된 기억을 떠올리게 하며, 자기 자신을 새로운 시각에서 바라보게 만든다는 사실은 오랫동안 임상 현장에서 활용되어 왔다(Hesley & Hesley, 2001). 이러한 경험적 토대 위에서 발전한 것이 영상치료(video therapy) 혹은 영화치료(cinema therapy)이며, 이는 내담자가 영상을 시청하거나 직접 제작·편집하는 과정을 통해 정서적 정화와 통찰을 얻도록 돕는 심리치료적 접근이다(Sacilotto et al., 2022). 국내에서도 영화치료는 우울증 중년여성, 위기청소년 등 다양한 대상에게 적용되어 정서 개선 효과가 보고되어 왔다(강은주, 천성문, 2011; 신경아, 2018).

2020 년대에 들어 생성형 인공지능은 텍스트뿐 아니라 이미지·음성·영상까지 생성하는 단계로 빠르게 진화했다. 특히 텍스트 프롬프트만으로 고품질 영상을 즉시 만들어 내는 텍스트-투-비디오 모델이 상용화되면서(Sun et al., 2024; Liu et al., 2024), 개인의 정서 상태·선호·목표에 맞춘 영상을 실시간으로 생성하는 일이 기술적으로 가능해졌다. 이로부터 'AI 영상치유'라는 새로운 개념이 부상하고 있으며, 국내 상담·심리치료 분야에서도 AI 활용 연구가 꾸준히 증가하고 있다(여수진, 손승희, 2025).

2. 문제 제기

그러나 기술적 가능성이 곧 치료적 타당성을 의미하지는 않는다. 영상치료의 치유 효과는 단지 '좋은 영상'을 보는 데서 나오는 것이 아니라, 치료자와 내담자 사이의 관계, 영상에 대한 해석과 대화, 안전한 치료적 환경 속에서의 정서 처리 과정에서 비롯되기 때문이다(Bordin, 1979; Cuijpers et al., 2019). 다시 말해 영상은 치유의 '재료'일 뿐, 치유 자체를 완성하는 것은 그 재료를 다루는 임상적 맥락이다. 이 점을 간과한 채 'AI 가 좋은 영상을 만들 수 있으니 치유도 자동화할 수 있다'는 기대가 확산된다면, 치료의 본질을 기술의 산출물로 환원하는 오류에 빠질 위험이 있다. 실제로 규제되지 않은 생성형 AI 정신건강 도구의 위험성은 비판적으로 제기되어 왔으며(Parks et al., 2025), 보건의료 AI 의 윤리·거버넌스에 대한 국제적 우려도 커지고 있다(World Health Organization, 2021).

그럼에도 현재의 논의는 기술 중심으로 치우쳐, 검증된 영상치료 이론의 관점에서 AI 영상치유의 가능성과 한계를 체계적으로 비교한 연구가 부족하다. 막연한 기대와 비판 사이에서, 치료 기제에 정박한 분석이 요청된다.

3. 연구 목적 및 연구 문제

본 연구의 목적은 영상치료의 치료 기제에 정박한 통합 분석틀을 구성하고, 이를 적용하여 AI 영상치유의 가능성과 한계를 비판적으로 비교·고찰함으로써, 책임 있는 도입 방향을 도출하는 데 있다. 이를 위해 다음의 연구 문제를 설정한다.

- **연구 문제 1.** 영상치료의 핵심 치료 기제와 이론적 근거는 무엇이며, 이를 AI 영상치유 평가에 적용할 분석틀은 어떻게 구성되는가?
- **연구 문제 2.** 구성된 분석틀에 비추어, AI 영상치유의 가능성은 무엇인가?
- **연구 문제 3.** 동일한 분석틀에 비추어 AI 영상치유의 한계는 무엇이며, 양자는 어떻게 통합될 수 있는가?

II. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 이론적 문헌고찰(theoretical literature review)을 연구 설계로 채택한다. 이는 새로운 실증 자료를 수집·검증하는 대신, 기존의 이론과 경험적 근거를 비판적으로 종합하여 개념적 분석틀을 구성하고 이를 특정 현상에 적용하는 방법으로, 실증연구가 아직 축적되지 않은 신생 영역의 쟁점을 선제적으로 규명하는 데 적합하다. 따라서 본 연구의 결론은 단정적 효과 평가가 아니라, 후속 실증연구를 위한 가설과 도입 원칙의 성격을 갖는다.

2. 문헌 검색 및 선정

문헌은 국외의 PubMed·PsycINFO·Google Scholar 와 국내의 KCI·RISS 를 대상으로 수집하였다. 검색어는 '영상치료/video therapy', '영화치료/cinema therapy', '치료적 동맹/therapeutic alliance', '생성형 AI/generative AI', '텍스트-투-비디오/text-to-video', '디지털 정신건강/digital mental health' 등을 조합하였다. 선정 기준은 (1)

영상·영화치료의 이론·기제·효과를 다룬 문헌, (2) 심리치료 공통요인·치료적 동맹에 관한 문헌, (3) 디지털·생성형 AI 정신건강 개입의 효과·위험·윤리를 다룬 문헌으로 하였다. 이론적 정박을 위해 해당 분야의 고전·1 차 문헌(seminal works)을 우선 포함하고, 신생 기술의 시의성을 위해 최근 문헌을 함께 포함하였다.

3. 분석틀

본 연구는 영상치료의 다섯 가지 핵심 기제—① 동일시와 투사, ② 정서적 정화(Yalom & Leszcz, 2020), ③ 보편성(Yalom & Leszcz, 2020), ④ 관찰학습(Bandura, 1977), ⑤ 치료적 대화의 매개(Bordin, 1979; Sacilotto et al., 2022)—를 통합하여 분석 렌즈를 구성하였다. 가능성과 한계는 모두 이 다섯 기제에 비추어 도출하며, 윤리적 한계는 보건의료·정신건강 AI 윤리 규범(World Health Organization, 2021; American Psychological Association, 2025)에 정박하여 분석한다.

Ⅲ. 이론적 배경: 영상치료(Video Therapy)

1. 영상치료의 개념과 유형

영상치료는 영상 매체를 매개로 하는 심리치료적 개입을 포괄하는 용어이다. Sacilotto 등(2022)은 영상치료를 크게 상업 영화를 활용하는 고전적 영화치료(classical cinematherapy)와, 특정 기술을 시연하는 영상을 통해 모방학습을 유도하는 비디오 모델링(video modeling)으로 구분하였다. 넓은 의미에서 영상치료는 다음을 포함한다.

- **영화치료(cinema therapy):** 내담자에게 호소 문제와 관련된 영화·장면을 처방·시청하게 하고, 동일시와 거리두기를 통해 자기 문제를 투사하고 통찰을 얻게 하는 접근이다. Hesley 와 Hesley(2001)는 이를 '비디오워크(videowork)'로 명명하고, 시청 후 치료자와의 대화를 통해 영화 속 인물의 갈등과 내담자의 경험을 연결하는 체계적 기법을 제시하였다.
- **비디오 자기표현·자기대면(video self-confrontation):** 내담자가 자신을 촬영한 영상을 보거나 직접 영상을 제작하여 자기 인식과 표현을 확장하는 접근이다. 자신을 객관적으로 관찰하는 과정에서 평소 의식하지 못한 행동·정서 패턴을 자각하게 된다.

- **비디오 모델링(video modeling)**: 특정 적응적 행동을 시연하는 영상을 관찰하게 하여 모방학습을 유도하는 접근으로, Bandura(1977)의 사회학습이론에 이론적 기반을 둔다.
- **영상 기반 회상·이완·심상유도**: 자연·명상·기억을 자극하는 영상으로 정서적 안정과 회상을 유도하는 접근이다.

2. 핵심 치료 기제

영상치료의 치유적 작용은 다음 기제들로 설명된다(Sacilotto et al., 2022).

1. **동일시와 투사(identification & projection)**: 내담자는 영상 속 인물·상황에 자신을 투영하여, 직접 말하기 어려운 감정과 갈등을 안전한 거리에서 다룬다. 국내 연구에서도 위기청소년 대상 집단영화치료가 동일시를 통해 정서조절력을 향상시키고 문제행동을 감소시킨 것으로 보고되었다(강은주, 천성문, 2011).
2. **정서적 정화(catharsis)**: 영상이 환기한 감정을 표출·경험함으로써 긴장이 해소되고 정서가 정리된다. 정화는 집단·개인 심리치료의 핵심 치료 요인으로 오랫동안 논의되어 왔으며(Yalom & Leszcz, 2020), 그 자체로 해소감을 줄 뿐 아니라 이후의 통찰을 위한 토대가 된다.
3. **보편성(universality)**: 비슷한 고통을 겪는 인물을 보며 '나만 그런 것이 아니다'를 경험하는 것은 고립감을 완화하는 강력한 치료 요인이다(Yalom & Leszcz, 2020). 영상의 서사는 이러한 보편성 경험을 효과적으로 매개한다.
4. **관찰학습과 정서 조절(observational learning & affect regulation)**: 영상 속 인물의 대처를 관찰함으로써 적응적 행동을 학습하며(Bandura, 1977), 안정적·심미적 영상 자극은 자율신경계를 안정시켜 스트레스를 완화한다. 실제로 영화치료 프로그램은 우울증 중년여성의 우울 감소와 정서표현성 향상에 효과가 있는 것으로 나타났다(신경아, 2018).
5. **치료적 대화의 매개(therapeutic mediation)**: 영상은 그 자체로 치유하는 것이 아니라, 시청 후 치료자와 나누는 대화·해석의 촉매로 기능한다. Sacilotto 등(2022)은 영상의 공유 시청이 치료자와 내담자 사이에 '공통의 언어(common vocabulary)'를 형성하여 치료적 관계를 강화한다고 보았다.

이 가운데 다섯 번째, 즉 영상이 치료적 관계와 대화 속에서 의미를 획득한다는 점은 본 연구의 비교 고찰에서 핵심 기준이 된다.

3. 치료적 동맹

심리치료 성과를 설명하는 공통요인 연구는 기법의 종류보다 치료적 관계가 성과를 더 잘 예측함을 일관되게 보고해 왔다(Cuijpers et al., 2019). Bordin(1979)은 이 관계를 목표(goals)·과제(tasks)·유대(bonds)로 구성된 작업동맹(working alliance)으로 개념화하고, 변화의 핵심이 동맹의 강도에 있다고 보았다. 다수 연구를 종합한 메타분석 역시 동맹이 치료 지향과 무관하게 성과를 예측하는 강력한 변인임을 확인하였다(Flückiger et al., 2018). 영상치료에서도 영상이라는 도구의 효과는 이 관계적 토대 위에서 발휘되며, 이 지점은 인간 치료자가 부재하거나 약화된 AI 영상치유의 구조적 한계를 평가하는 준거가 된다.

IV. AI 영상치유의 개념과 현황

1. 기술적 토대

AI 영상치유의 기술적 기반은 디퓨전 트랜스포머(diffusion transformer) 계열의 텍스트-투-비디오 모델로, 자연어 프롬프트로부터 고해상도 영상을 생성한다(Sun et al., 2024; Liu et al., 2024). 여기에 사용자의 정서 상태·선호·이력을 반영하는 개인화 알고리즘과, 언어적 입력을 해석해 적절한 영상·음성·텍스트를 제공하는 대화형 멀티모달 상호작용이 결합된다. 정서·행동 지원을 목적으로 한 생성형 AI 챗봇은 이미 다양하게 시도되고 있다(Wang et al., 2025).

다만 이 기술은 본질적 한계를 지닌다. 생성 결과는 학습 데이터의 통계적 패턴에 기반하므로 의도와 다른 산출과 세부 통제의 불완전성, 학습 데이터 편향을 내포하며, 산출 근거에 대한 설명가능성이 낮다(Sun et al., 2024).

2. 디지털 정신건강 맥락

AI 영상치유는 보다 넓게는 디지털 정신건강 흐름의 일부이다. 정신건강 서비스의 접근성 격차, 인력 부족, 비용 부담을 배경으로 앱·챗봇·VR 등 디지털 개입이 확산되어 왔다. 176 편의 무작위통제연구(RCT)를 종합한 메타분석은 정신건강 앱이 우울·불안 증상 완화에 유의한 효과가 있음을 보고하였고(Linardon et al., 2024), 92 편의 RCT 분석 역시 디지털 개입이 통제집단 대비 임상적 결과를 개선함을 확인하였으며(Valentine et al.,

2025), 생성형 AI 챗봇을 다룬 메타분석은 일정한 효과 가능성을 시사한다(Zhang et al., 2025). 다만 효과성·안전성의 근거는 여전히 축적 중이며, 특히 생성형 AI 기반 도구의 임상적 검증은 초기 단계에 머물러 있다(Wang et al., 2025).

V. 분석틀: 영상치료 기제에 기반한 비교 렌즈

앞의 이론을 종합하면, AI 영상치유를 평가하기 위한 비교 분석틀을 〈표 1〉과 같이 구성할 수 있다. 영상치료의 각 기제는 AI 영상치유가 강화할 수 있는 지점(가능성)과 충족하기 어려운 지점(한계)을 동시에 드러내는 렌즈로 기능한다.

〈표 1〉 영상치료 기제에 기반한 AI 영상치유 분석틀

치료 기제	AI가 강화할 수 있는 지점	AI가 충족하기 어려운 지점
동일시·투사	개인 맞춤 심상으로 투사 촉진	투사의 임상적 해석 부재
정서적 정화(Yalom & Leszcz, 2020)	즉시·반복 정서 환기	정화 이후의 담아내기 부재
보편성(Yalom & Leszcz, 2020)	맞춤 서사 제공	진정한 인간적 연결의 결여
관찰학습(Bandura, 1977)	맞춤 모델링 영상 생성	학습의 전이·강화 미보장
대화의 매개(Bordin, 1979)	콘텐츠 생성 보조	관계적 의미 처리 불가

이 분석틀은 다음 두 장(VI·VII)에서 가능성과 한계를 도출하는 준거가 된다.

VI. 비교 고찰: 가능성

1. 접근성(accessibility)

시간·공간·비용의 제약 없이 누구나 이용할 수 있다. 전문 인력이 부족한 지역이나 대면 치료에 대한 심리적 장벽이 높은 사용자에게 1차적 정서 지원 통로가 될 수 있다. 이는 디지털 정신건강 개입이 공통적으로 지니는 강점으로, 저비용·확장성 측면에서 공중보건적 의의가 크다(Linardon et al., 2024).

2. 맞춤형(personalization)

기성 영상을 '처방'하던 방식과 달리, 개인의 정서·기억·선호에 부합하는 콘텐츠를 생성할 수 있다. 분석틀에 비추면, 이는 동일시·투사와 심상유도의 효과(Sacilotto et al., 2022)를 이론적으로 강화할 잠재력을 지닌다. 정확히 자신을 비추는 영상은 투사를 촉진하고 보편성 경험을 정교화할 수 있다.

3. 즉시성과 반복성(immediacy & repeatability)

필요한 순간에 즉시 콘텐츠를 제공하고, 사용자가 원하는 만큼 반복·조정할 수 있다. 정서적 위기나 불안이 고조되는 순간은 정규 치료 시간과 일치하지 않는 경우가 많은데, AI 영상치유는 그 즉각성의 공백을 메울 수 있다. 이는 정화와 정서 조절을 목적으로 한 자기조력(self-help)에 특히 유리하다.

4. 표현의 확장(creative augmentation)

언어로 표현하기 어려운 내면을 영상으로 외화(externalize)하도록 도와, 자기표현의 도구를 확장한다. 트라우마나 복합적 정서처럼 말로 옮기기 어려운 경험도 '내가 느끼는 것을 영상으로 만들어 본다'는 과정을 통해 다룰 수 있는 대상이 된다. 이는 비디오 자기표현치료가 수행하던 외재화 기능을 생성 기술로 확장하는 것으로 볼 수 있다.

VII. 비교 고찰: 한계

1. 치료적 관계의 부재

가장 근본적인 한계이다. 영상치료의 효과는 치료적 동맹과 사후 대화 속에서 발현되는데(Bordin, 1979; Cuijpers et al., 2019; Flückiger et al., 2018), AI는 진정한 공감·신뢰·관계적 유대를 제공하지 못한다. 분석틀의 다섯 번째 기제, 즉 '대화의 매개'가 충족되지 못하는 것이다. AI는 영상을 생성할 수는 있어도, 그 영상의 의미를 내담자와 함께 처리하는 임상적 과정을 대체하기 어렵다. 국내 상담사들도 챗봇의 기능적 유용성은 인정하면서 관계적·정서적 깊이의 한계를 지적한 바 있다(장규현, 서영석, 2022).

2. 의미 처리의 피상화

영상치료에서 정화·보편성·동일시는 모두 사후의 의미 처리를 통해 치료적 변화로 전환된다(Yalom & Leszcz, 2020). 그러나 AI 영상치유에서는 치료자가 담당하던 '해석'의 역할이 사용자 자신에게 이전되어, 정서적 환기가 통찰로 통합되지 못한 채 표면적 자극에 머물 위험이 있다. 즉, 정화가 일어나도 이를 담아내고 의미화하는 과정이 부재하면 일시적 위안에 그칠 수 있다.

3. 근거 기반의 부족

AI 영상치유의 치료 효과를 검증한 통제된 실증연구는 매우 제한적이다. 생성형 AI의 치료적 적용은 유망한 결과를 보고하면서도 실제 현장 배치와 안전성 보장은 제한적이라는 평가가 지배적이며(Wang et al., 2025), 챗봇 기반 개입의 메타분석조차 효과크기의 이질성과 안전성 검증의 부족을 지적한다(Zhang et al., 2025). 기대와 마케팅이 근거를 앞서는 상황에 대한 경계가 필요하다.

4. 윤리적·법적 쟁점

개인의 정서·기억 데이터를 다루는 데 따른 프라이버시, 알고리즘 편향, 책임 소재의 불분명함이 핵심 쟁점이다. 보건의료 알고리즘이 사회적 약자에게 체계적으로 불리하게 작동할 수 있음은 이미 실증적으로 드러났으며(Obermeyer et al., 2019), WHO(2021)와 미국심리학회(American Psychological Association, 2025)는 자율성·프라이버시·책임성·형평성을 핵심 윤리 원칙으로 제시한다. 인간 치료자를 값싼 자동화로 대체하려는 경향은 이러한 윤리적 위험을 심화시킬 수 있다.

5. 진정성과 깊이의 문제

AI가 생성한 심상이 표면적 위안에는 효과적일 수 있으나, 무의식·서사·상징을 깊이 다루는 치유 작업에는 한계가 있을 수 있다. 영화의 서사가 갖는 힘은 인간 창작자의 의도·맥락·문화적 상징이 응축된 데서 비롯되는데(Hesley & Hesley, 2001), 통계적 패턴으로 생성된 영상이 이러한 상징적 깊이를 담보하는지는 불확실하다. 또한 사용자가 '나를 위해 즉시 만들어진 것'임을 인지하는 순간, 인간이 만든 작품을 마주할 때의 정서적 울림이나 의미 부여가 약화될 가능성도 있다. 즉, 맞춤형이 오히려 진정성을 훼손하는 역설이 발생할 수 있다.

6. 종합 비교

이상의 가능성과 한계를 주요 기준별로 정리하면 <표 2>와 같다.

<표 2> 기존 영상치료와 AI 영상치유의 비교

기준	기존 영상치료	AI 영상치유
콘텐츠	기성·표준 영상 처방	개인 맞춤 영상 즉시 생성
접근성	치료자·시공간 제약	높음(언제·어디서나)
치료적 관계	핵심 기제로 작동	부재 또는 모사에 그침
의미 처리	치료자와의 대화로 심화	자동화·피상화 위험
근거	상대적으로 축적	매우 부족
윤리 위험	통상적 임상 윤리	데이터·편향·책임 쟁점 추가
진정성	인간 창작의 상징적 깊이	통계적 생성의 진정성 의문

VIII. 논의

1. 통합 모델: 치료자 매개형 적용

비교 고찰의 결과는 AI 영상치유가 기존 영상치료를 대체하는 것이 아니라 보완하는 방향으로 자리매김할 때 가장 큰 가치를 가짐을 시사한다. 본 연구는 다음 통합 모델을 제안한다.

- 1. 치료자 매개형(therapist-mediated) 모델:** 치료자가 AI 를 활용해 내담자 맞춤 영상을 신속히 제작하고, 그 해석과 정서 처리는 치료적 관계 안에서 수행한다. AI 는 콘텐츠 생성 도구, 인간은 치유의 주체로 역할을 분담함으로써, VII장에서 지적인 '관계의 부재'와 '의미 처리의 피상화'를 구조적으로 보완한다.
- 2. 단계적 케어(steppped-care) 모델:** 경증·자기조력 단계에서는 AI 영상치유를 1 차 접근 통로로 활용하고, 위험 신호가 감지되면 전문 인력으로 연계한다. 이는 접근성이라는 AI 의 강점(Linardon et al., 2024)을 치료 체계 안에 안전하게 위치시킨다.
- 3. 윤리·안전 거버넌스 내장:** 데이터 보호, 편향 점검, 위기 대응, 책임 구조를 시스템에 필수 요소로 내장한다(World Health Organization, 2021; American Psychological Association, 2025).

2. 이론적 함의

본 연구는 산재한 영상치료 기제를 신생 기술 평가를 위한 통합 분석틀로 재구성하였다. 이들은 AI 영상치유뿐 아니라 향후 등장할 디지털 영상 개입을 평가하는 데 확장 적용될 수 있으며, '기술이 무엇을 할 수 있는가'가 아니라 '치료 기제가 무엇을 요구하는가'에서 출발하는 관점을 제시한다.

3. 임상적·정책적 함의

임상적으로 AI 영상치유는 치료자를 대체하는 자율적 치료가 아니라 임상가의 통제 아래 콘텐츠 생성을 보조하는 도구로 위치 지어져야 한다. 정책적으로는 효과성·안전성 검증, 데이터 보호, '치료'를 표방하는 검증되지 않은 서비스에 대한 규율이 요구된다.

IX. 결론 및 제언

본 연구는 영상치료의 치료 기제에 정박한 통합 분석틀을 구성하고, 이를 적용하여 AI 영상치유의 가능성과 한계를 비교·고찰하였다. AI 영상치유는 접근성·맞춤성·즉시성·표현 확장이라는 가능성을 지니나, 치료적 관계의 부재, 의미 처리의 피상화, 근거 부족, 윤리적 위험, 진정성의 문제라는 본질적 한계를 안고 있다. 따라서 AI 영상치유는 인간 치료자를 대체하는 자율적 치유 수단이 아니라, 치료자가 매개하는 보조 도구로 통합될 때 그 잠재력이 책임 있게 실현될 수 있다.

본 연구는 이론적 고찰에 머문다는 점, 빠르게 변화하는 기술의 특정 시점을 다룬다는 점에서 한계를 지닌다. 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 통제된 설계로 AI 영상치유의 효과성과 부작용을 검증하는 실증연구가 필요하다. 둘째, 데이터 보호·위기 대응·편향 점검에 관한 윤리·안전 가이드라인의 수립이 요구된다. 셋째, 치료자-AI 협업의 구체적 임상 절차를 개발·검증하는 연구가 필요하다.

본 연구는 빠르게 확산되는 디지털 치유 기술을 검증된 치료 이론의 관점에서 비판적으로 성찰할 이론적 토대와 분석틀을 제공했다는 데 의의가 있다.

참고문헌 (References)

APA 7 판 형식. 국내 문헌은 가나다순, 국외 문헌은 알파벳순으로 정렬하였다.
실제 제출 시 둘째 줄 들여쓰기(hanging indent)를 적용할 것.

국내 문헌

강은주, 천성문 (2011). 집단영화치료프로그램이 위기청소년의 정서조절력과 문제행동에 미치는 효과 연구. *청소년상담연구*, 19(2), 23-46.

<https://doi.org/10.35151/kyci.2011.19.2.002>

신경아 (2018). 우울증 증년여성을 위한 영화치료 프로그램의 효과. *디지털융복합연구*, 16(10), 511-522. <https://doi.org/10.14400/JDC.2018.16.10.511>

여수진, 손승희 (2025). AI 기반 심리상담 연구의 국내 동향 분석: 주제범위 문헌고찰을 중심으로. *상담심리교육복지*, 12(5), 11-27.

<https://doi.org/10.20496/cpew.2025.12.5.11>

장규현, 서영석 (2022). 심리상담 챗봇에 대한 상담사들의 인식. *상담학연구*, 23(6), 17-48.

<https://doi.org/10.15703/kjc.23.6.202212.17>

국외 문헌

American Psychological Association. (2025). *Balancing promise and risk: Ethical considerations for GenAI in mental health care*. APA Services.

<https://www.apaservices.org/practice/ce/expert/ethical-genai-mental-health-care>

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.

Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 16(3), 252-260. <https://doi.org/10.1037/h0085885>

Cuijpers, P., Reijnders, M., & Huibers, M. J. H. (2019). The role of common factors in psychotherapy outcomes. *Annual Review of Clinical Psychology*, 15, 207-231. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095424>

- Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. *Psychotherapy, 55*(4), 316–340. <https://doi.org/10.1037/pst0000172>
- Hesley, J. W., & Hesley, J. G. (2001). *Rent two films and let's talk in the morning: Using popular movies in psychotherapy* (2nd ed.). Wiley.
- Linardon, J., Cuijpers, P., Carlbring, P., Messer, M., & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2024). Current evidence on the efficacy of mental health smartphone apps for symptoms of depression and anxiety: A meta-analysis of 176 randomized controlled trials. *World Psychiatry*.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10785982/>
- Liu, Y., Zhang, K., Li, Y., Yan, Z., Gao, C., Chen, R., Yuan, Z., Huang, Y., Sun, H., Gao, J., He, L., & Sun, L. (2024). *Sora: A review on background, technology, limitations, and opportunities of large vision models* [Preprint]. arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.17177>
- Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science, 366*(6464), 447–453. <https://doi.org/10.1126/science.aax2342>
- Parks, A., Travers, E., Perera-Delcourt, R., Major, M., Economides, M., & Mullan, P. (2025). Is this chatbot safe and evidence-based? A call for the critical evaluation of generative AI mental health chatbots. *Journal of Participatory Medicine, 17*(1), e69534. <https://doi.org/10.2196/69534>
- Sacilotto, E., Salvato, G., Villa, F., Salvi, F., & Bottini, G. (2022). Through the looking glass: A scoping review of cinema and video therapy. *Frontiers in Psychology, 12*, Article 732246. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.732246>
- Sun, R., Zhang, Y., Shah, T., Sun, J., Zhang, S., Li, W., Duan, H., Wei, B., & Ranjan, R. (2024). *From Sora what we can see: A survey of text-to-video generation* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.10674>

- Valentine, L., Hinton, J. D. X., Bajaj, K., Boyd, L., O'Sullivan, S., Sorenson, R. P., Bell, I. H., Sobredo Vega, M., Liu, P., Peters, W., Mangelsdorf, S. N., Wren, T. W., Moller, C., Cross, S., McEnery, C., Bendall, S., Nicholas, J., & Alvarez-Jimenez, M. (2025). A meta-analysis of persuasive design, engagement, and efficacy in 92 RCTs of mental health apps. *npj Digital Medicine*, 8, Article 229. <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01567-5>
- Wang, X., Zhou, Y., & Zhou, G. (2025). The application and ethical implication of generative AI in mental health: Systematic review. *JMIR Mental Health*, 12, e70610. <https://doi.org/10.2196/70610>
- World Health Organization. (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2020). *The theory and practice of group psychotherapy* (6th ed.). Basic Books.
- Zhang, Q., Zhang, R., Xiong, Y., Sui, Y., Tong, C., & Lin, F.-H. (2025). Generative AI mental health chatbots as therapeutic tools: Systematic review and meta-analysis of their role in reducing mental health issues. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e78238. <https://doi.org/10.2196/78238>